

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR - UNICESUMAR
CURSO DE DIREITO - 3º SEMESTRE NOTURNO, TURMA B

ACADÊMICOS DO 3º SEMESTRE NOTURNO – TURMA B

PROJETO DE EXTENSÃO: EFEITO REBOTE

MARINGÁ - PR

2026

3º SEMESTRE NOTURNO, TURMA B

PROJETO DE EXTENSÃO: EFEITO REBOTE

Projeto de extensão apresentado à disciplina de Direito Penal, Curso Bacharel em Direito, Universidade Cesumar - Unicesumar Câmpus Maringá.

Orientadora: Profª Camila Viríssimo

Coordenadora: Profª Simone

MARINGÁ - PR

2026

RESUMO

Palavras-chave:

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. HIPÓTESE.....	5
3. PROBLEMA.....	5
4. OBJETIVO GERAL.....	5
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
5. JUSTIFICATIVA.....	5
6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
7. IDENTIDADE VISUAL E PRODUÇÃO DE MATERIAIS.....	5
8. METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO.....	6
9. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE CRONOGRAMA.....	6
12. CONCLUSÃO.....	6
REFERÊNCIAS.....	6

1. INTRODUÇÃO

2. HIPÓTESE

3. PROBLEMA

4. OBJETIVO GERAL

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar condições que coloquem apenados em situação de risco;
- Promover o acolhimento às famílias daqueles em reclusão;
- Realizar busca e arrecadação de insumos conforme a necessidade das instituições PEM, CCM e CPIM;
- Promover campanhas de doação para as instituições PEM, CCM e CPIM;
- Estimular nos acadêmicos de direito o pensamento crítico, humanístico e de cidadania;
- Promover na sociedade em geral a responsabilidade social.

5. JUSTIFICATIVA

A extensão universitária integra, ao lado do ensino e da pesquisa, o tripé que sustenta a educação superior brasileira. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 207, estabelece que as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988), o que evidencia que a formação acadêmica não deve se restringir ao ambiente da sala de aula, mas alcançar também o contato com a realidade social. Nesse sentido, a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, editada para regulamentar a Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação então vigente (Lei nº 13.005/2014), determinando que as atividades de extensão componham, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação, devendo integrar a matriz curricular (BRASIL, 2014; BRASIL, 2018).

Para além de uma exigência normativa, a extensão aproxima o estudante das demandas concretas da sociedade. As diretrizes nacionais orientam que tais ações sejam direcionadas, prioritariamente, a áreas de grande pertinência social (BRASIL, 2018), permitindo que o conhecimento produzido no ambiente universitário retorne à comunidade sob a forma de reflexão, orientação e proposição de soluções. No âmbito do curso de Direito, essa vivência revela-se especialmente relevante, uma vez que possibilita ao acadêmico compreender a aplicação prática das normas jurídicas e os efeitos que delas decorrem sobre a vida dos indivíduos.

O projeto "Efeito Rebote: o custo da reincidência" insere-se nessa proposta ao abordar o sistema prisional brasileiro sob a perspectiva da reincidência criminal e de seus reflexos sociais e econômicos. Ao tratar desse tema, os acadêmicos são conduzidos a relacionar os conteúdos estudados em disciplinas como Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal a uma questão que repercute diretamente na segurança pública e na destinação dos recursos estatais. Dessa forma, o projeto busca contribuir para o desenvolvimento do senso crítico, da responsabilidade social e da capacidade de análise técnico-jurídica de seus participantes.

Além do aprendizado teórico, a experiência extensionista favorece o desenvolvimento de

competências práticas, tais como o trabalho em equipe, a organização de atividades, a comunicação com o público e a gestão de recursos, habilidades igualmente exigidas no exercício profissional. Assim, o projeto de extensão cumpre dupla função: contribui para a formação de acadêmicos mais preparados para a atuação jurídica e reafirma o compromisso da instituição de ensino superior com a transformação da realidade social.

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

6.1. A IMPORTÂNCIA DOS ITENS BÁSICOS DE HIGIENE NO AMBIENTE PRISIONAL

A garantia do acesso contínuo a itens básicos de higiene pessoal e de higienização sanitária nas unidades prisionais masculinas constitui elemento para a salvaguarda da dignidade humana e a preservação da integridade física da população privada de liberdade (Sá et al., 2008). Em que pese a previsão legal de assistência material e sanitária disposta na Lei de Execução Penal (Gois et al., 2012), a literatura científica documenta uma realidade marcada pela escassez crônica ou ausência de insumos elementares de higiene pessoal. Essa carência material submete os detentos a um cotidiano de degradação ambiental, comprometendo os padrões mínimos de habitação e convivência no cárcere (Minayo; Ribeiro, 2016; Lôbo et al., 2022).

Pesquisa-ação desenvolvida em unidades prisionais masculinas do Estado do Rio de Janeiro evidencia que a indisponibilidade de insumos sanitários gera um sentimento difuso de impotência diante do ambiente contaminado, compartilhado por detentos e agentes de segurança penitenciária (Sá et al., 2008). Nesses estabelecimentos, a interrupção periódica no fornecimento de água potável, somada à rotina de servir refeições no interior de celas superlotadas (razão de 1,39 presos por vaga em levantamento no Rio de Janeiro e de até 2,2 no Pará), favorece o acúmulo de resíduos orgânicos e a atração de insetos e vetores (Minayo; Ribeiro, 2016; Lôbo et al., 2022). Diante da omissão ou insuficiência do aparato estatal na provisão de tais suprimentos,

os familiares dos apenados frequentemente assumem o ônus de fornecer os itens de higiene pessoal e os medicamentos de uso rotineiro (Sá et al., 2008).

Em síntese, os estudos focados no sistema carcerário demonstram que a precariedade na distribuição de materiais de higiene atua em sinergia com a superlotação das celas e a infraestrutura física insalubre, deteriorando as condições de saúde física e inviabilizando a atenção integral aos custodiados (Gois et al., 2012; Lôbo et al., 2022). Constata-se, assim, que a ausência desses insumos básicos não representa mero desconforto, mas um determinante ambiental primário que expõe a população carcerária masculina a riscos sanitários evitáveis. Dessa forma, o fornecimento regular e adequado de itens de higiene configura medida elementar de prevenção sanitária e garantia de direitos fundamentais, cuja inobservância instaura o elo inicial de degradação da saúde no sistema prisional.

6.2. A RELAÇÃO ENTRE HIGIENE INADEQUADA E PROBLEMAS DE SAÚDE

A literatura científica voltada ao sistema prisional demonstra que as condições inadequadas de higiene e saneamento mantêm forte associação com o surgimento e a proliferação de diversos agravos à saúde física dos custodiados (Gois et al., 2012; Minayo; Ribeiro, 2016). Sob a perspectiva metodológica, a relação entre higiene precária e o adoecimento no cárcere não deve ser interpretada como uma causalidade biológica isolada ou direta, mas sim como uma associação multifatorial, na qual a falta de insumos sanitários atua de forma indissociável e sinérgica com a superlotação, a má qualidade do ar, a alimentação inadequada e o estresse do confinamento (Gois et al., 2012; Minayo; Ribeiro, 2016; Lôbo et al., 2022).

Dentre os acometimentos de saúde associados à precariedade higiênica em presídios, destacam-se as enfermidades dermatológicas (Sá et al., 2008; Minayo; Ribeiro, 2016). Em pesquisa-ação realizada especificamente em unidades prisionais masculinas, Sá et al. (2008) constataram que a vivência em ambientes sujos e a indisponibilidade de produtos de limpeza e higiene pessoal são diretamente associadas, nos relatos cotidianos de agentes e detentos. Complementarmente, em inquérito com 1.573 detentos no Rio de Janeiro (amostra representativa da população carcerária do estado, com 1.110 homens), Minayo e Ribeiro (2016) registraram

elevada prevalência autorreferida de doenças de pele nos 12 meses anteriores, sobressaindo-se alergias e dermatites alérgicas (43,4%) e úlceras, eczemas ou psoríase (15,9%).

No campo das doenças transmissíveis e respiratórias, a insalubridade do confinamento e a ausência de higienização do espaço físico constituem determinantes críticos de vulnerabilidade no sistema (Sá et al., 2008; Lôbo et al., 2022). O aprisionamento em celas mal ventiladas e superlotadas favorece a disseminação de patógenos, destacando-se a tuberculose pulmonar e o HIV como as principais ameaças infecciosas percebidas por agentes e encarcerados (Sá et al., 2008).

Em síntese, a literatura científica confirma que a falta de higiene atua como um fator de risco ambiental e multiplicador de agravos dermatológicos, respiratórios e infecciosos no sistema prisional. Embora as evidências comprovem a forte correlação entre ambientes insalubres e o adoecimento de homens encarcerados, não é possível atribuir a ocorrência dessas patologias exclusivamente à ausência de itens de higiene, dado o caráter indissociável dos demais fatores de degradação carcerária. Assim, estabelece-se como hipótese fundamentada que a garantia de condições adequadas de higienização e o fornecimento contínuo de materiais de higiene pessoal constituem uma medida preventiva capaz de mitigar a incidência e a severidade desses problemas de saúde na população prisional masculina.

6.3. AS CONSEQUÊNCIAS DOS PROBLEMAS DE SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL

Quando uma pessoa privada de liberdade adoece no ambiente prisional, o Estado precisa mobilizar a estrutura de atenção à saúde existente dentro da unidade e, quando ela não é suficiente, recursos assistenciais e logísticos externos (Gois et al., 2012; Fernandes et al., 2014; Lôbo et al., 2022). A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, determina que a atenção à saúde do preso tenha caráter preventivo e curativo e compreenda atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover essa assistência, ela deve ser prestada em outro local, mediante autorização da direção (Gois et al., 2012). No mesmo sentido, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) prevê equipes semelhantes às da Estratégia Saúde da Família, capazes de resolver os problemas de nível

primário e de garantir a referência para os serviços de média e alta complexidade, inclusive as urgências. No Estado de São Paulo, a Deliberação CIB-62/2012 fixou como equipe mínima um médico, um odontologista, um enfermeiro e dois auxiliares de enfermagem para cada 500 a 1.200 detentos (Fernandes et al., 2014).

Na prática, porém, a assistência interna não segue esse modelo. Em levantamento realizado em unidades prisionais paulistas, Fernandes et al. (2014) verificaram que, embora frequentemente houvesse um profissional de referência, ele não cumpria toda a jornada e atuava mais em pronto atendimento do que em ações de promoção, prevenção e tratamento dos agravos mais comuns. Os autores apontam, ainda, a provável existência de grande demanda reprimida. No Rio de Janeiro, os presos relataram a falta de médicos após as 16 horas e aos finais de semana, o que contraria a previsão de atendimento contínuo (Minayo; Ribeiro, 2016).

O cuidado prestado dentro da unidade também depende de insumos e de serviços de apoio diagnóstico que nem sempre estão disponíveis. O estudo paulista abrangeu 34 centros de detenção provisória (CDPs), 69 unidades prisionais masculinas e seis femininas. Nele, cerca de 60% das unidades relataram falta de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios e benzodiazepínicos. Os exames laboratoriais eram colhidos na própria unidade, mas os resultados demoravam a ser entregues. Nos exames de imagem, a dificuldade aumentava com a complexidade do exame, de 9% para radiografias a 71% para tomografias (Fernandes et al., 2014). No Rio de Janeiro, os presos descreveram a distribuição de medicamentos como precária ou quase inexistente. Quando os remédios prescritos, inclusive os de uso contínuo, não estavam disponíveis, cabia às famílias comprá-los, quando tinham condições (Minayo; Ribeiro, 2016).

Mesmo o atendimento realizado dentro do presídio exige a participação dos agentes prisionais. São eles que retiram o paciente da cela, fazem a revista, conduzem o preso e garantem a segurança durante o procedimento. Por isso, o encontro entre paciente e profissional de saúde fica sujeito às exigências de segurança e à rotina da unidade (Lôbo et al., 2022). Quando o caso exige atenção secundária, terciária ou de urgência, o preso precisa ser encaminhado à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) fora do estabelecimento penal (Gois et al., 2012; Fernandes et al., 2014). Em São Paulo, esse fluxo é dificultado porque mais de 60% das unidades prisionais estão em cidades pequenas, sem estrutura de saúde para garantir atendimento secundário ou terciário.

Em Serra Azul, por exemplo, sempre que um preso precisa desse tipo de cuidado, ele deve ser transferido para Ribeirão Preto (Fernandes et al., 2014).

O deslocamento para atendimento externo concentra os principais obstáculos. No levantamento paulista, a falta de escolta foi o problema mais citado para os encaminhamentos de saúde. Ela foi apontada por 53 das 69 penitenciárias masculinas (76,8%) e por 21 dos 34 CDPs (61,7%). Nas penitenciárias masculinas, também foram relatadas a falta de ambulância (20 unidades; 29,0%) e a falta de vaga na unidade de saúde receptora (22 unidades; 31,9%). Os autores registram, ainda, que o excesso de encaminhamentos gerou mais pedidos de escolta do que era possível atender (Fernandes et al., 2014). No Rio de Janeiro, o transporte é feito pelo Grupamento de Serviço de Escolta (GSE), que leva cerca de 400 presos por dia a fóruns e unidades de saúde, em veículos precários e sob relatos de maus-tratos. Como o transporte é ligado à área de segurança, e não à de saúde, faltam ambulâncias. Por causa dos maus-tratos no trajeto, muitos presos adiam ao máximo os pedidos de atendimento que exigem saída da unidade (Minayo; Ribeiro, 2016). No Pará, o principal polo penitenciário fica a 36 quilômetros do laboratório do sistema prisional, e as unidades do interior dependem de avião ou barco para chegar à região metropolitana de Belém. Por isso, grande parte dos profissionais recorre a serviços externos para o diagnóstico. Segundo relato de uma enfermeira do sistema, muitos casos suspeitos de tuberculose são diagnosticados por radiografias feitas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima (Lôbo et al., 2022).

Em síntese, as fontes analisadas indicam que um problema de saúde no cárcere não se resolve apenas no plano clínico. Ele pode mobilizar medicamentos, exames, profissionais de saúde, agentes prisionais, escoltas, veículos e serviços da rede externa do SUS. As falhas na atenção primária dentro das unidades, como jornadas incompletas, falta de medicamentos e demora nos exames, somadas às barreiras de deslocamento, favorecem a demanda reprimida e o atraso no cuidado. Os estudos não medem diretamente quantos agravos se tornam mais graves por esse motivo. Por isso, formula-se como hipótese que a precariedade da saúde nas prisões gera sobrecarga operacional e financeira indireta sobre a saúde pública e a segurança, e que medidas preventivas na atenção primária podem reduzir a necessidade de acionar posteriormente recursos de maior custo.

6.4. O IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PROBLEMA

A assistência à saúde no sistema prisional brasileiro tem base normativa própria desde o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), instituído pela Portaria Interministerial nº 1.777/2003. Esse plano tornou a população prisional, pela primeira vez, objeto de uma política de saúde específica (Gois et al., 2012). Em 2014, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) integrou a unidade de saúde prisional à rede de atenção, ampliou os tipos de equipes e ajustou o incentivo financeiro. Como a adesão de estados e municípios é facultativa, nem toda a assistência está vinculada ao SUS (Lôbo et al., 2022). Os estudos analisados mostram, contudo, que a estrutura existente não tem sido suficiente para atender à demanda. No Pará, entre 2012 e 2018, a população prisional cresceu 75,6% e chegou a 19.284 custodiados. O número absoluto de profissionais de saúde aumentou, mas a proporção por mil presos diminuiu. Nesse período, a cobertura das equipes de saúde prisional vinculadas ao SUS chegou, no máximo, a 45,8% da população custodiada (Lôbo et al., 2022). Em São Paulo, os medicamentos disponíveis nas unidades eram os previstos no Programa Dose Certa, mas cerca de 60% das unidades pesquisadas em 2009 relataram falta de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios e benzodiazepínicos (Fernandes et al., 2014).

O impacto também aparece na logística dos atendimentos externos. Em São Paulo, mais de 60% das unidades prisionais estavam em cidades pequenas, sem estrutura para garantir atendimento secundário ou terciário (Fernandes et al., 2014). Em Serra Azul, a população carcerária correspondia a 40% ou mais da população do município. Como cabe ao município a atenção básica e a oferta de serviços secundários e terciários acompanha a população residente, os autores consideram previsível que o maior problema relatado seja a continuidade do atendimento nesses níveis. Por isso, os presos precisam ser transferidos para Ribeirão Preto, o que exige escolta e aumenta a "população flutuante" de familiares que acompanham o detento e que também podem precisar do sistema de saúde. A falta de escolta foi o problema mais citado para os encaminhamentos, relatado por 76,8% das penitenciárias masculinas (53 de 69) e por

61,7% dos CDPs (21 de 34). Nas penitenciárias masculinas, também foram relatadas a falta de ambulância (29,0%) e a falta de vaga na unidade receptora (31,9%). Os autores registram, ainda, que a longa duração das escoltas pode deixar a população em geral desguarnecida (Fernandes et al., 2014). No Rio de Janeiro, o GSE transportava cerca de 400 presos por dia para fóruns e unidades de saúde. Os problemas relatados incluíam excesso de pessoas transportadas, dificuldades operacionais, estrutura precária para o traslado e maus-tratos (Minayo; Ribeiro, 2016).

Quanto aos recursos humanos, o número de profissionais nem sempre se traduz em melhor atendimento. Em São Paulo, a maioria das equipes estava próxima da composição proposta pela Comissão Intergestores Bipartite, sem que isso se refletisse em melhoria dos indicadores. Nas penitenciárias masculinas, as medianas eram de 1,0 médico, 0,9 odontologista, 1,01 enfermeiro e 3,5 auxiliares de enfermagem por mil detentos (Fernandes et al., 2014). No Pará, o sistema chegou a contar com mais de seis psicólogos, dois médicos, dois dentistas, dois enfermeiros e 12 técnicos de enfermagem por mil custodiados. Mesmo assim, o número mensal de consultas variou muito, de forma imprevisível, o que dificulta o planejamento das ações de saúde (Lôbo et al., 2022). Há também um impacto social sobre as famílias. Quando os medicamentos prescritos não estão disponíveis no presídio, são elas que os compram, quando podem. Para Minayo e Ribeiro (2016), o sistema carcerário provoca um impacto social e de saúde desproporcional na vida dos presos e de suas famílias, que em sua maioria vivem em áreas urbanas socialmente desfavorecidas.

Em síntese, as fontes indicam que as deficiências da atenção primária nas unidades prisionais têm efeitos econômicos e sociais. Há demanda por escoltas, veículos e vagas na rede externa, sobrecarga dos municípios onde estão os presídios e transferência de parte dos custos com medicamentos para as famílias. Os estudos analisados, porém, não apresentam valores em reais gastos com saúde e logística prisional, nem comparam o custo da prevenção com o do tratamento. Assim, formula-se como hipótese a ser verificada que fortalecer a atenção primária e garantir condições adequadas de higiene nas unidades pode contribuir para reduzir os custos posteriores com remoções, urgências e tratamentos de maior complexidade no sistema prisional.

6.6. A PREVENÇÃO COMO ALTERNATIVA DE MENOR CUSTO POTENCIAL

Aqui vocês apresentam a solução que o projeto pretende discutir.

O que deve conter

Pesquisem sobre a perspectiva preventiva:

- importância da prevenção de doenças;
- higiene como medida preventiva;
- fornecimento de produtos básicos;
- prevenção versus tratamento;
- eventualmente, estudos que comparem custos de prevenção e custos de tratamento.

Depois, se houver dados suficientes, vocês podem comparar:

Custo preventivo

aquisição/distribuição dos itens de higiene.

versus

Custo potencial decorrente da ausência

atendimento + medicamentos + exames + deslocamento + outros recursos documentados.

A pergunta que você precisa responder

Existe fundamento para considerar o fornecimento de itens básicos de higiene como uma medida preventiva potencialmente menos onerosa do que lidar posteriormente com determinados problemas de saúde?

Essa formulação é melhor do que simplesmente afirmar:

"Doar é mais barato."

Porque "doar é mais barato" é uma conclusão econômica que precisa de dados.

Função do 6.6

Chegar à ideia de:

prevenção de baixo custo → possível redução de problemas → possível redução de custos posteriores.

6.7. RELAÇÃO ENTRE A PESQUISA E A AÇÃO EXTENSIONISTA

Este último tópico fecha a fundamentação e devolve o trabalho para aquilo que ele realmente é: extensão universitária.

O próprio projeto prevê ações sociais, participação dos estudantes, organização de itens, montagem de kits, entrega e reflexão sobre os impactos da atividade.

O que deve conter

Aqui vocês explicam:

- qual foi a ação realizada;
- por que a ação foi escolhida;
- quais itens foram arrecadados;
- como ocorreu a mobilização;
- quem participou;
- para quem os itens foram destinados;
- qual foi o resultado da arrecadação;
- o que os estudantes observaram;
- qual relação existe entre a ação prática e o problema estudado.

A pergunta que você precisa responder

Como a ação de extensão atua sobre o problema identificado na pesquisa?

Função do 6.7

Mostrar que a pesquisa não foi feita apenas para produzir texto.

Ela serviu para compreender um problema social e fundamentar uma ação concreta.

6.4 O Efeito Rebote da Omissão Estatal

A insuficiência da assistência material destinada às pessoas privadas de liberdade pode produzir consequências que ultrapassam a privação inicialmente experimentada no ambiente prisional. Entre os elementos dessa assistência estão materiais básicos de higiene e cuidados pessoais, diretamente relacionados às condições de saúde, salubridade e dignidade. Quando esses recursos não são fornecidos de forma suficiente e regular, podem surgir consequências para a pessoa privada de liberdade, seus familiares e para a própria Administração Pública.

Nesse contexto, o presente projeto utiliza a expressão “efeito rebote” como uma categoria de análise para compreender o encadeamento de consequências decorrentes da insuficiência da assistência material. A ausência ou insuficiência de itens básicos de higiene pode contribuir para o agravamento das condições sanitárias e de saúde no ambiente prisional, gerando demandas posteriores que exigem novas intervenções do Poder Público, como atendimentos de saúde, deslocamentos, escoltas e outras providências administrativas.

Assim, uma situação que poderia ser enfrentada preventivamente mediante o fornecimento adequado de materiais básicos pode contribuir para o surgimento de demandas posteriores de maior complexidade. O chamado efeito rebote representa, portanto, a possibilidade de que os efeitos da insuficiência inicial da assistência retornem ao próprio Estado sob a forma de novas demandas e custos.

Esse fenômeno também pode alcançar os familiares das pessoas privadas de liberdade. Quando determinados materiais não são disponibilizados adequadamente pelo estabelecimento prisional, os familiares podem assumir, na prática, parte dos custos relacionados à aquisição desses produtos. Dessa forma, uma insuficiência na prestação da assistência material estatal pode gerar impactos econômicos e sociais sobre o núcleo familiar, além de dificultar a manutenção dos vínculos durante o cumprimento da pena.

A intervenção proposta pelo projeto Efeito Rebote não pretende solucionar o problema estrutural da assistência material no sistema prisional nem substituir a responsabilidade estatal

pela garantia desses direitos. A arrecadação e a entrega de materiais de higiene constituem uma intervenção pontual, voltada à mitigação de uma das consequências concretas dessa insuficiência. Ao mesmo tempo, permitem aos acadêmicos observar, na prática, os efeitos sociais e institucionais relacionados ao problema estudado.

Dessa forma, o “efeito rebote” é utilizado como uma perspectiva analítica para compreender a relação entre a insuficiência da assistência material e suas possíveis consequências sociais, econômicas, sanitárias e institucionais. A intervenção extensionista atua de maneira delimitada sobre uma dessas dimensões, possibilitando também uma reflexão crítica sobre o problema.

6.7 A importância da extensão para a formação acadêmica

A realização do projeto de extensão possui relevância para a formação dos estudantes de Direito por aproximar o conhecimento desenvolvido no ambiente universitário da realidade concreta do sistema prisional. A experiência permite que conteúdos relacionados à execução penal, aos direitos das pessoas privadas de liberdade, à assistência material e à dignidade da pessoa humana sejam analisados não apenas de forma teórica, mas também a partir de suas manifestações práticas.

A participação nas etapas de pesquisa, organização, arrecadação, triagem, visitas técnicas e entrega dos materiais proporciona aos acadêmicos contato direto com uma realidade social que, muitas vezes, é conhecida principalmente por meio da legislação, da doutrina e dos estudos acadêmicos. Essa aproximação contribui para ampliar a compreensão sobre a diferença entre a previsão formal de direitos e sua efetiva concretização no sistema prisional.

Além disso, a experiência possibilita compreender que a atuação jurídica não se limita à aplicação abstrata das normas. O contato com situações concretas permite identificar como as garantias previstas no ordenamento jurídico repercutem na vida das pessoas e nas estruturas

institucionais. Dessa forma, o projeto contribui para o desenvolvimento de uma formação mais crítica, humanística e comprometida com a realidade social.

A extensão também favorece a articulação entre ensino, pesquisa e prática, uma vez que os conhecimentos desenvolvidos academicamente são utilizados para compreender um problema concreto, enquanto a experiência obtida durante o projeto possibilita novas reflexões sobre o objeto estudado.

Portanto, a arrecadação e a entrega de materiais de higiene representam apenas uma das dimensões do projeto. Sua relevância acadêmica também está na possibilidade de transformar o conhecimento jurídico em experiência prática, permitindo aos estudantes compreender de maneira mais concreta os desafios relacionados à efetivação dos direitos das pessoas privadas de liberdade e contribuindo para uma formação profissional associada ao conhecimento técnico, à responsabilidade social e à capacidade crítica.

7. IDENTIDADE VISUAL E PRODUÇÃO DE MATERIAIS

8. METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

9. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE CRONOGRAMA

12. CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

GOIS, Swyanne Macêdo et al. **Para além das grades e punições: uma revisão sistemática sobre a saúde penitenciária.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 5, p. 1235-1246, 2012.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; RIBEIRO, Adalgisa Peixoto. **Condições de saúde dos presos do estado do Rio de Janeiro, Brasil.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 7, p. 2031-2040, 2016.

FERNANDES, Luiz Henrique; ALVARENGA, Carlos Willie; SANTOS, Luciane Loures dos; PAZIN FILHO, Antonio. **Necessidade de aprimoramento do atendimento à saúde no sistema carcerário.** *Revista de Saúde Pública*, v. 48, n. 2, p. 275-283, 2014.

LÔBO, Nancy Meriane de Nóvoa et al. **Análise do cuidado em saúde no sistema prisional do Pará, Brasil.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 12, 2022.

SÁ, Maria Cecília de et al. **Saúde em prisões: representações e práticas dos agentes de segurança penitenciária no Rio de Janeiro, Brasil.** *Cadernos de Saúde Pública*, v. 24, n. 8, 2008.

LIMA, Fabiane da Silva Severino et al. **Estratégias educativas para prevenção de infecções femininas no presídio: revisão de escopo.** *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 37, 2024, eAPE003246.